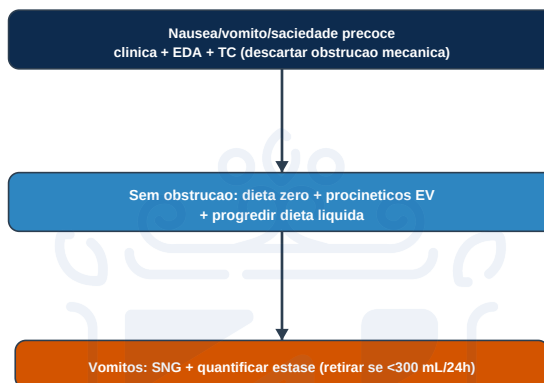


GASTROPARESIA — PROCINÉTICO + EXCLUIR OBSTR.

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

GASTROPARESIA — EXCLUIR OBSTRUÇÃO -> PROCINÉTICO



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

O QUE É

- Síndrome de retardo do esvaziamento gástrico NA AUSÊNCIA de obstrução mecânica, com sintomas
- Etiologia: idiopática, DM tipo 1 (neuropatia autonômica), lesão do nervo vago (pós-cirúrgica)
- Medicamentos: análogos de GLP-1, opioides
- Clínica: náusea, vômito, saciedade precoce, dor abdominal, perda de peso
- Diagnóstico: clínica + EDA; TC de abdome para DESCARTAR obstrução mecânica (essencial)

TRATAMENTO NA URGÊNCIA

Rx PROCINÉTICOS + DIETA

Dieta zero inicial + goma de mascar (estímulo)

Procinéticos: Bromoprida 10 mg EV 8/8h; Metoclopramida 10 mg EV 8/8h; Domperidona 10 mg VO 8/8h

Progredir a dieta conforme aceitação, iniciando por dieta LÍQUIDA

Se vômitos: passar SNG nº 18 e quantificar a estase gástrica

Retirar a SNG quando o débito for < 300 mL/24h

ORIENTAÇÕES NA ALTA

MANEJO AMBULATORIAL

- Refeições em pequenas porções, fracionadas
- Evitar alimentos gordurosos, ácidos e picantes (retardam o esvaziamento)
- Hidratação e suporte nutricional
- Manter procinéticos conforme orientação
- Otimizar a causa de base (controle glicêmico no DM; revisar opioides/GLP-1)

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com náusea/vômito/saciedade precoce; causa provável ____ (DM/vagotomia/medicação).
- Obstrução mecânica EXCLUÍDA (EDA/TC): ____; estase gástrica/débito de SNG: ____.
- Conduta: dieta zero, procinético ____, progressão de dieta líquida; SNG se vômitos.
- Encaminhamento à gastro para investigação/seguimento; otimizar causa de base.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual passo é indispensável antes de firmar o diagnóstico de gastroparesia?

- A) Iniciar opioide
- B) Descartar obstrução mecânica (EDA/TC)
- C) Suspender hidratação
- D) Indicar cirurgia
- E) Solicitar colonoscopia

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a classe medicamentosa de escolha no tratamento da gastroparesia?

- A) Opioides
- B) Procinéticos (bromoprida, metoclopramida, domperidona)
- C) Antibióticos
- D) Corticoides
- E) Anti-histamínicos

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual causa medicamentosa pode levar a gastroparesia?

- A) Análogos de GLP-1 e opioides
- B) Paracetamol
- C) Amoxicilina
- D) Vitamina C
- E) Dipirona

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quando retirar a sonda nasogástrica colocada por vômitos na gastroparesia?

- A) Imediatamente após a passagem
- B) Quando o débito for < 300 mL/24h
- C) Somente após 7 dias fixos
- D) Nunca retirar
- E) Apenas em centro cirúrgico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual orientação dietética é adequada na gastroparesia?

- A) Grandes refeições ricas em gordura
- B) Pequenas porções, evitando alimentos gordurosos, ácidos e picantes
- C) Jejum prolongado permanente
- D) Apenas alimentos sólidos volumosos
- E) Dieta hipercalórica em poucas refeições grandes

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A gastroparesia é definida na AUSÊNCIA de obstrução mecânica; por isso é indispensável descartá-la com EDA e TC de abdome antes de firmar o diagnóstico.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os procinéticos (bromoprida, metoclopramida, domperidona) são a classe de escolha, acelerando o esvaziamento gástrico.

QUESTÃO 3 → Resposta: A

Análogos de GLP-1 e opioides retardam o esvaziamento gástrico e podem causar/agravar gastroparesia — revisar essas medicações faz parte do manejo.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A SNG colocada por vômitos/estase deve ser retirada quando o débito cair para < 300 mL/24h, indicando melhora do esvaziamento.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Orienta-se refeições em pequenas porções, fracionadas, evitando alimentos gordurosos, ácidos e picantes, que retardam o esvaziamento gástrico.

SM24
Suporte ao Plantão Médico